



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : فتحه عبد الحميد عبد الرحمن احمد

المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : الزيتون

العنوان : شيوخ عوض الزيتون

رقم البطاقة : 25308252601421 رقم التليفون : 01008857508

تاريخ تسجيل الإستمارة : 24-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 25-08-1953 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني	الوظيفة: -----	التوقيع: -----
الاسم: د/ندى حسن	الوظيفة: -----	التوقيع: -----
الاسم: د/نرمين رمضان	الوظيفة: -----	التوقيع: -----

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /أ.د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: فتحه عبد الحميد عبد الرحمن احمد National ID: 25308252601421	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

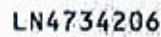
نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: فتحية عبد الحميد عبدالرحمن
احمد

Age: 73 years

Sex: female

Request type: مبادره

Sub request type:

Hospital no:

Pathology no.: 744-2026

Department: صحة مرآه

Date of result: 8/8/2026

Referred by: د/مروه حسن

Date of biopsy: 30/7/2026

Nature of specimen: tru-cut biopsy

I.D. Number: 25308252601421

Clinical diagnosis: Right breast mass

Gross pathology :

Multipite grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: ER- PR- Her2- Ki67

Microscopic picture: Section examined revealed core of tumor showing invasive mammary carcinoma of no special type (NST). The tumor forms nests, tubule and single cells and files infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing moderate anaplasia and moderate tendency to form tubules. There is moderate number of mitotic figures.

Immunohistochemical Result:

ER: Positive strong nuclear staining in 90% of tumor cells (Allred Score 8/8).

PR: Moderate nuclear staining of 90% of tumor cells (Allred Score 7/8).

Her2: Moderate incomplete membranous staining of >10% tumor cells (score

2+) Equivocal for SISH

Ki67: Positive nuclear staining of 50% of tumor cells.

Diagnosis: Right breast mass, tru cut biopsy:

Invasive mammary Carcinoma, (NST) Grade II.

Signature:

Dr.Mona Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

كود المريض: 97715	اسم المريض بالإنجليزية: Fatehiah Abd Alhamid Abdalrahman
السن: ٧٢ سنة، ١١ شهر	تاريخ التقرير: 2026/07/30 11:17:04 AM

Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: right breast palpable lump

Technique: Medio-lateral oblique and CC views & High resolution ultrasound

Detailed Findings

Mammographic findings:

- Scattered fibroglandular densities (ACR-b)
- **Right breast:**
 - Global asymmetry with upper outer quadrant and central parenchymal distortion
 - Associated UOQ middle third pleomorphic microcalcifications in linear distribution
 - Moderate diffuse skin thickness and trabecular thickening
 - Right axilla showing multiple lobulated hyperdense lesions with effaced central lucency suggestive of pathologic lymph nodes
- **Left breast:**
 - UOQ middle third tubular convoluted hyperdensities in segmental distribution
 - Few scattered calcific foci in random distribution
 - Normal skin thickness and contour. Normal nipple / areola complex.

Ultrasound findings:

- Heterogeneous fibroglandular breast parenchyma- predominant glandular
- **Right breast:**
 - UOQ and central 8-1 o'clock extensive pathological process evident as multiple amalgamated heterogeneous hypoechoic solid lesions with posterior shadowing, internal echogenic foci likely representing calcifications, marked internal vascularity of low resistance arterial waveform pattern in complementary color Doppler study
 - The lesion showing evidence of ductal extension reaching the nipple
 - Moderate diffuse skin thickness and interstitial edema evident as edematous echogenic and linear hypoechoic collections in between
 - More than 5 level I axillary lymph nodes with globular shape, diffuse cortical thickness and effaced hila; the largest measuring 2.4 x 2.1 cm
 - Single level II axillary lymph node with cortical thickness up to 4 mm
- **Left breast:**
 - Dilated retroareolar ducts with echogenic content showing no prominent internal vascularity in complementary color Doppler study
 - Normal skin and subcutaneous tissue. Normal nipple / areola complex
 - Non-specific axillary lymph nodes with preserved oval shape, average cortical thickness and central echogenic hilum

Impression:

- **Right breast (BIRADS 5):** upper outer and central extensive pathologic process reaching the nipple with ipsilateral pathologic axillary lymph nodes as described (BIRADS 5), ultrasound guided biopsy was taken from the lesion in the same setting
- **Left breast (BIRADS 3):** duct ectasia with probably benign intraductal lesions as described for contrast enhanced study to evaluate any pathologic enhancement

Dr. Lamiaa Elsharkawy, MD.

 جوستافا روني 9-20		مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية	السلطة المصرية للطب مصر
			09/20/2026
MDT FORM			
Name: فتحه عبدالحميد عبدالرحمن احمد		MRN: 13192	
Age: 73 Y		ID: 25308252601421	
Menopausal Sta post		Phone:* 01008857508	
NRS SCORE:		Marital Status: married	
BMI:		Family History: -ve	
Gender		Reason Of MDT:	
CO Morbidity: m. free		NEW	
Surgical History:* NAD		ECOG Performance Status 0 1 2 3 4	

Clinical Data:

BX: rt IDC 2
ER: 8/8 **PR:** 5/8 **HER2:** 1+ **KI67:** 30%

History:**Sonomammography:**

rt skin thickness + edema + UOQ extensive pathological process + PLN
+ LT duct ectasia + intraductal lesion BIRAD 3 PROBABLY BENIGN
INTRADUCTAL LESION

Biomarker/Molecular

Luminal B

Mets Workup:

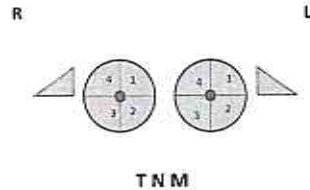
CT CAP free

Recommendations:

for NACT then RT MRM

MDT Outcome & Plan

PORT-CTH
ECHO
NA ACX4 TTX4 EVALUATION EVERY 2 CYCLES BY US
THE RT MRM



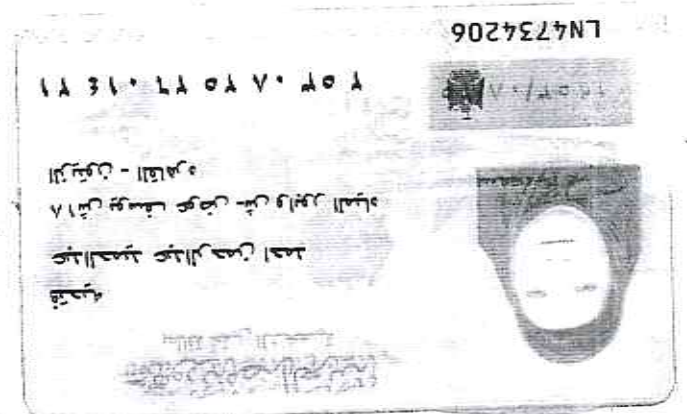
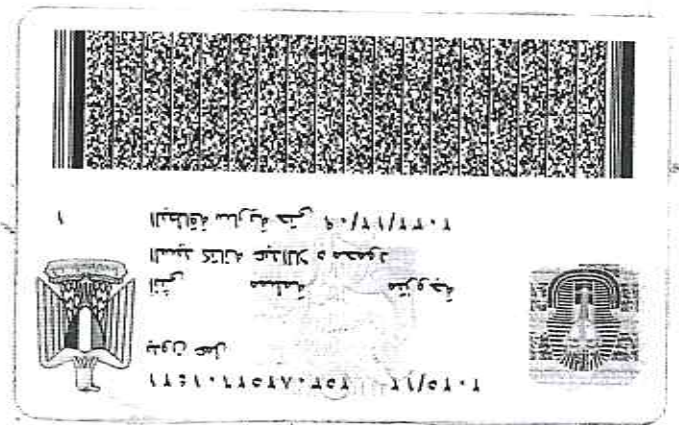
Right Side				Left Side			
Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4

Clinical Staging:

T4D N2 M0

Pathological Staging:**SIGNATURE**

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د محمد كيلاني	د محمد نوراني		



رقم القسي

وزارة الصحة العامة والتأهيل الاجتماعي

وزارة الصحة العامة والتأهيل الاجتماعي

محمود عبد الله

الموظف المختص

تاريخ الطابع: 2026-7-30

25308252601421 رقم القسي

2026-7-30 تاريخ الطابع

الهيئة العامة للتأمين الصحي

الوزارة المركزية للنظم المعلوماتية

الرقمي

2026/07/30 11:17:04 AM : تاريخ التقرير	Dr. Lamiaa Elsharkawy, MD.
Fatehiah Abd Alhamid Abdalrahman : اسم المريض باللاتيني د. الجريش : 97715	Dr. Lamiaa Elsharkawy, MD.

Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: right breast palpable lump

Technique: Medio-lateral oblique and CC views & High resolution ultrasound

Detailed Findings

Mammographic findings:

- Scattered fibroglandular densities (ACR-b)

Right breast:

- Global asymmetry with upper outer quadrant and central parenchymal distortion

Left breast:

- Associated UOQ middle third pleomorphic microcalcifications in linear distribution

Right breast:

- Moderate diffuse skin thickness and trabecular thickening

Left breast:

- Right axilla showing multiple lobulated hyperdense lesions with effaced central lucency suggestive of pathologic lymph nodes

Ultrasound findings:

- Heterogeneous fibroglandular breast parenchyma- predominant glandular

Right breast:

- UOQ and central 8-1 o'clock extensive pathological process evident as multiple amagmated heterogeneous hypoechoic solid lesions with posterior shadowing, internal echogenic foci likely representing calcifications, marked internal vascularity of low resistance arterial waveform in complementary color Doppler study

Left breast:

- The lesion showing evidence of ductal extension reaching the nipple

Right breast:

- Dilated retroareolar ducts with echogenic content showing no prominent internal vascularity in complementary color Doppler study

Left breast:

- Normal skin and subcutaneous tissue. Normal nipple / areola complex

Right breast:

- Non-specific axillary lymph nodes with preserved oval shape, average cortical thickness and central echogenic hilum

Left breast:

- Single level II axillary lymph node with cortical thickness up to 4 mm

Right breast:

- More than 5 level I axillary lymph nodes with globular shape, diffuse cortical thickness and effaced hila; the largest measuring 2.4 x 2.1 cm

Left breast:

- Internal vascularity in complementary color Doppler study

Right breast:

- Dilated retroareolar ducts with echogenic content showing no prominent internal vascularity in complementary color Doppler study

Left breast:

- Normal skin and subcutaneous tissue. Normal nipple / areola complex

Right breast:

- Non-specific axillary lymph nodes with preserved oval shape, average cortical thickness and central echogenic hilum

Left breast:

- Single level II axillary lymph node with cortical thickness up to 4 mm

Right breast:

- More than 5 level I axillary lymph nodes with globular shape, diffuse cortical thickness and effaced hila; the largest measuring 2.4 x 2.1 cm

Left breast:

- Internal vascularity in complementary color Doppler study

Right breast:

- Dilated retroareolar ducts with echogenic content showing no prominent internal vascularity in complementary color Doppler study

Left breast:

- Normal skin and subcutaneous tissue. Normal nipple / areola complex

Right breast:

- Non-specific axillary lymph nodes with preserved oval shape, average cortical thickness and central echogenic hilum

Left breast:

- Single level II axillary lymph node with cortical thickness up to 4 mm

Right breast:

- More than 5 level I axillary lymph nodes with globular shape, diffuse cortical thickness and effaced hila; the largest measuring 2.4 x 2.1 cm

Left breast:

- Internal vascularity in complementary color Doppler study



PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: **عبدالله بن محمد بن علي** Age: 73 years Sex: female

Request type: **علاج**
Hospital no: **5555**
Department: **قسم الباثولوجي**
Referred by: **د. محمد بن علي**
Nature of specimen: **tru-cut biopsy**
Clinical diagnosis: **Right breast mass**

Gross pathology: **Multiple grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.**

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against ER- PR.

Her2- Ki67

Micoscopic picture: Section examined revealed core of tumor showing invasive mammary carcinoma of no special type (NST). The tumor forms nests, tubule and single cells and files infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing moderate anaplasia and moderate tendency to form tubules. There is moderate number of mitotic figures.

Immunohistochemical Results

ER: Positive strong nuclear staining in 90% of tumor cells (Allred Score 8/8).
PR: Moderate nuclear staining of 90% of tumor cells (Allred Score 7/8).
Her2: Moderate incomplete membranous staining of >10% tumor cells (score 2+)
Ki67: Positive nuclear staining of 50% of tumor cells.

Diagnosis: **Right breast mass, tru cut biopsy:
Invasive mammary Carcinoma, (NST) Grade II.**

Signature:

Dr. Mona Mohamed, M.D.

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D.



Gustave Roussy International-Egypt-Pathology Lab
مركز جوستاف روسي للطب والجراحة - مصر



Patient Name	فادية عبدالعظيم عبدالعظيم	Case No.	360803
Sex/Age	Female 73 Y	Patient No.	25858
Registered Date	26/8/2026 03:52:28 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	07/9/2026 01:25:29 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	16/9/2026 09:23:56 AM	Pathology No.	SR-943/26

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer.

Nature of Specimen: Block revision.

Gross Examination:

- One paraffin block labelled by (744 B-26).

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for:
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 2 (differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1).
- DCIS: Absent.
- Microcalcification: Absent.
- Angiolymphatic invasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.
- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): Mild.

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 5% of tumor cells (score 5/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 1+).
- Ki67: 30%.

Conclusion:

Right breast mass, Block revision (Tru-cut biopsy):
- Invasive duct carcinoma, Grade 2.
IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 5/8).



Room No. (4) - First Floor-Building No. 987-Nile Corniche - Mistr El Qadema - Cairo, Egypt
مركز جوستاف روسي للطب والجراحة - مصر - القاهرة - مبنى رقم 987 - طابق الأول - غرفة رقم (4)



Gustave Roussy International-Egypt Pathology Lab
مركز جوستاف روسي الدولي للطب - مصر



Patient Name	فادية عبدالحاميد عبدالحاميد	Case No.	360803
Sex/Age	Female 73 Y	Patient No.	25858
Registered Date	26/8/2026 03:52:28 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	07/9/2026 01:25:29 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	16/9/2026 09:23:56 AM	Pathology No.	SR-943/26

- Her2: Low (score 1+).

- Ki67: 30%.

****Scoring system: "ER, PR"**
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

****Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within > 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim, MD.



Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mistr El Qadima - Cairo, Egypt
مركز جوستاف روسي الدولي للطب - (4) - طابق أول - مبنى رقم 987 - نيل كورنيش - ميسر القديما - القاهرة، مصر

- ❖ Right breast multicentric lesions with axillary lymphadenopathy for sono-mammography.
- ❖ No pulmonary or hepatic metastatic lesions.

Opinion:

- No ascites.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Both kidneys are normal size, average sized and showing smooth regular cortical outline and or dilated biliary radicles.
- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Bilateral elastofibroma dorsa.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.
- No pleural or pericardial collection.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No consolidation or collapse.
- No pulmonary nodules, masses or cavity lesions.
- Diffuse mosaic attenuation of both lungs likely small airway disease.
- Right axillary lymph node measuring 39 x 25 mm.
- Right breast heterogeneous parenchyma with multicentric lesions largest measuring 64 x 24 mm for sono-mammography.

I- CHEST:

Known case of breast CA.

AND PELVIS REVEALED:

MULTISLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN

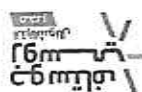
Patient's Name: Fathiya Abdul Hamid Abdul Rahman Ahmed
Referred by: Prof. Dr. no doctor
Date: 2026-08-26
Hospital: Goustave Roussey International Egypt



Dr.sherif Wagdy

Patient's Name:
Date:
Referred by:
Hospital:

Fathiya Abdul Hamid Abdul Rahman Ahmed
2026-08-26
Prof.Dr. no doctor
Goustave Roussey International Egypt



الاسم:	فخيم عبد المصطفى عبد الرحمن
الرقم القومي:	٢٠٤٦٠٥٥٨٠٩١
رقم التليفون:	٨٨٥٧٥٠٨ - ١
التاريخ:	١٣١٧ هـ / ٢٠١٦ م

☐ مستهدفة بالتوعية والإفصاح الإكلينيكي

قياس ضغط	قياس السكر العشوائي	مؤشر كتلة الجسم	الطول	الوزن
100/60	75		1.00m	74

*فكري نفسك باستمرار بموعد الفحص الذاتي شهرياً

2025	نوفمبر		2025	أكتوبر		2025	سبتمبر
2026	فبراير		2026	يناير		2025	ديسمبر
2026	مايو		2026	أبريل		2026	مارس
2026	أغسطس		2026	يوليو		2026	يونيو
2026	نوفمبر		2026	أكتوبر		2026	سبتمبر
2027	فبراير		2027	يناير		2026	ديسمبر
2027	مايو		2026	أبريل		2027	مارس
2027	أغسطس		2027	يوليو		2027	يونيو

حافظي علي قياس السكر والضغط مرة كل ٦ شهور

إذا كنتي في سن الزواج أو الإنجاب، استشاري طبيب تخليم الأسرة

- إطمئني ، الكشف المبكر يساعد في السيطرة على الأمراض، وزيادة نسبة الشفاء.

[illegible]

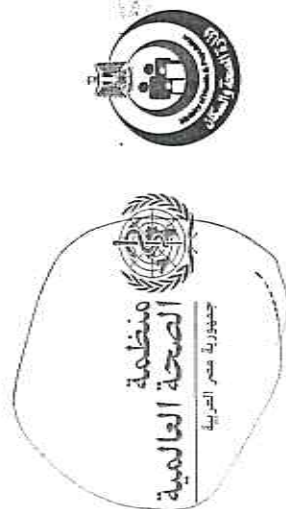
توقيع الطبيب: _____

المكان المحولة له للتقييم: موقع النظم

مفتی محمد رفیع الرحمن

15335

www.100millionseha.eg



پیشہ ورانہ تعلیم

تعرفني على كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي

الخطوة الرابعة (على السرير)

- استلقي على السرير، استخدم يدي اليسرى لفحص الثدي الأيمن واليد اليمنى لفحص الثدي الأيسر.

- باستخدام أطراف أصابعك و من خلال حركة دائرية، قومي بفحص الثدي (الجلد والأنسجة).

- تأكدي من فحص الثدي بالكامل من أعلى إلى أسفل، ومن جانب إلى جانب - من عظمة الترقوة إلى أعلى بطنك، ومن الإبط إلى منتصف الصدر.

- حتى تتأكدي من فحص الثدي بالكامل، يمكنك أن تبداي من الحلمة ثم تتحركي في دوائر أكبر وأكبر حتى تصلين إلى المنطقة الخارجية للثدي.

- يمكنك أيضاً تحريك أصابعك لأعلى ولأسفل رأسياً.

- لاحظي الإحساس بأي من العلامات التالية:

الشعور بأورام بالإبط الشعور بسمك عام



الم بالثدي ورم محسوس



الخطوة الخامسة (أثناء الإستحمام)

- اعيدي الفحص السابق بنفس الطريقة المذكورة أثناء الإستحمام والجلد مبتل.

- أفضل توقيت للقيام بفحص الذاتي للثدي بعد آخر يوم في الدورة الشهرية أو في حالة إنقطاع الدورة الشهرية حدي يوم ثابت شهرياً لإجراء الفحص.

الخطوة الأولى (أمام المرأة)

- انظري إلى الثديين في المرأة مع وضع اليدين في وضع مستقيم على الجانبين ثم وضع اليدين على الوسط.

- تأكدي بالنظر إلى شكل ولون وحجم الثديين، وأنه هو المعتاد بالنسبة لك في دون تغيير أو دون اختلاف بين الثديين.

- لاحظي وجود أي من العلامات التالية بأي من الثديين:

بروز الأوردة تغير في الشكل أو الحجم حدوث تجوف طفق



تجاعيد بالجلد تحول الجلد لما يشبه قشر البرتقال الإحمرار تراجع أو تغيير في اتجاه الحلمة



الخطوة الثانية (أمام المرأة)

- أرفعي يديكي إلى أعلى وتأكدي من عدم وجود أي من التغييرات السابقة

الخطوة الثالثة (أمام المرأة)

- أثناء رفع يديكي إلى أعلى، لاحظي خروج أي إفرازات غير طبيعية أو دم من الحلمتين اليمنى أو اليسرى

إفرازات غير طبيعية أو دم



- في حال ملاحظة أي من العلامات السابقة توجهي إلى عيادة صحة المرأة بالوحدة الصحية

 		MDT FORM	
Name:	القبة عبدالرحمن احمد	MRN:	13192
Age:	73 Y	ID:	25308252601421
Menopausal Sta	post	Phone:*	01008857508
NRS SCORE:		Marital Status:	married
BMI:		Family History:	-ve
Gender		Reason Of MDT:	NEW
CO Morbidity:	m. free	ECOG Performance Status	0 0 1 2 3 4
Surgical History:*	NAD		

Clinical Data:

BX: rt IDC 2
ER: 8/8 **PR:** 5/8 **HER2:** 1+ **KI67:** 30%

History:Sonomammography:

rt skin thickness + edema + UOQ extensive pathological process + PLN
 + LT duct ectasia + intraductal lesion BIRAD 3 PROBABLY BENIGN
 INTRADUCTAL LESION

Biomarker/Molecular

Luminal B

Mets Workup:

CT CAP free

Recommendations:

for NACT then RT MRM

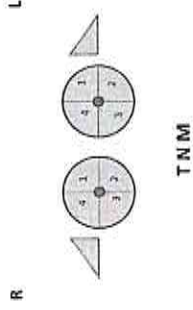
MDT Outcome & Plan

PORT-CTH

ECHO

NA ACX4 TTX4 EVALUATION EVERY 2 CYCLES BY US

THE RT MRM



Right Side

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Left Side

Clinical Staging:

T4D N 2 M0

Pathological Staging:SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د محمد كبرلي	د محمد نوراني		



جمهورية مصر العربية
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

فخريه

عبد الحميد عبدالرحمن احمد

١٨ اش يوسف عوض ش واور المباد
الريثون - القاهره

٢٥٣.٨٢٥٢٦.١٤٢١

LN4734206



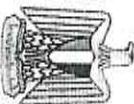
٢٠٣٥/١٢
٢٥٣.٨٢٥٢٦.١٤٢١
بدون عمل

متروجه

مستلمه

اش السيد كنانه عبداللاد محمود

البطاقة ساريه حتى ٢٠٣٢/١٢/٠٩



فاتهياہ عبد الحمید عبدالرحمان : الاسم المرضي بالخطير	97715 : كود المريض
2026/07/30 11:17:04 AM : تاريخ الفحص	النسبة : النسبة ٧٧ سنة ١١ شهر

Bilateral Full field Digital Mammography

Clinical summary: right breast palpable lump

Technique: Medio-lateral oblique and CC views & high resolution ultrasound

Detailed Findings

Mammographic findings:

- Scattered fibroglandular densities (ACR-b)

▪ Right breast:

- Global asymmetry with upper outer quadrant and central parenchymal distortion
- Associated UOQ middle third pleomorphic microcalcifications in linear distribution
- Moderate diffuse skin thickness and trabecular thickening
- Right axilla showing multiple lobulated hyperdense lesions with effaced central lucency suggestive of pathologic lymph nodes

▪ Left breast:

- UOQ middle third tubular convoluted hyperdensities in segmental distribution
- Few scattered calcific foci in random distribution
- Normal skin thickness and contour. Normal nipple / areola complex.

Ultrasound findings:

- Heterogeneous fibroglandular breast parenchyma- predominant glandular

▪ Right breast:

- UOQ and central 8-1 o'clock extensive pathological process evident as multiple amalgamated heterogeneous hypoechoic solid lesions with posterior shadowing, internal echogenic foci likely representing calcifications, marked internal vascularity of low resistance arterial waveform pattern in complementary color Doppler study
- The lesion showing evidence of ductal extension reaching the nipple
- Moderate diffuse skin thickness and interstitial edema evident as edematous echogenic and linear hypoechoic collections in between
- More than 5 level I axillary I lymph nodes with globular shape, diffuse cortical thickness and effaced hila; the largest measuring 2.4 x 2.1 cm
- Single level II axillary lymph node with cortical thickness up to 4 mm

▪ Left breast:

- Dilated retroareolar ducts with echogenic content showing no prominent internal vascularity in complementary color Doppler study
- Normal skin and subcutaneous tissue. Normal nipple / areola complex
- Non-specific axillary lymph nodes with preserved oval shape, average cortical thickness and central echogenic hilum

Impression:

- **Right breast (BIRADS 5):** upper outer and central extensive pathologic process reaching the nipple with ipsilateral pathologic axillary lymph nodes as described (BIRADS 5), **ultrasound guided biopsy was taken from the lesion in the same setting**
- **Left breast (BIRADS 3):** duct ectasia with probably benign intraductal lesions as described for contrast enhanced study to evaluate any pathologic enhancement

Dr. Lamiaa Elsharkawy, MD.



MINISTRY OF HEALTH

قسم الباثولوجيا

مبنى العامة للمستشفيات والعيادات الخارجية
مبنى القوي لكبد والحوائل الهضمية
الأمرافق الصحية

PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: سند عبد الحبيب عبد الجبار حسن Age: 73 years Sex: female

Request type: مبارك Sub request type:

Hospital no: Pathology no.: 744-2026

Department: مصلحة مرضى النساء والولادة Date of result: 8/8/2026

Referred by: د. محمد بن عبد الله Date of biopsy: 30/7/2026

Nature of specimen: tru-cut biopsy I.D. Number: 25308252601421

Clinical diagnosis: Right breast mass

Gross pathology :

Multiple grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: ER- PR- Ki67- Ki67

Microscopic picture: Section examined revealed core of tumor showing invasive mammary carcinoma of no special type (NST). The tumor forms nests, tubule and single cells and files infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showing moderate anaplasia and moderate tendency to form tubules. There is moderate number of mitotic figures.

Immunohistochemical Result:

ER: Positive strong nuclear staining in 90% of tumor cells (Allred Score 8/8).

PR: Moderate nuclear staining of 90% of tumor cells (Allred Score 7/8).

Her2: Moderate incomplete membranous staining of >10% tumor cells (score

2+) Equivocal for 3IS4

Ki67: Positive nuclear staining of 50% of tumor cells.

Diagnosis: Right breast mass, tru cut biopsy:

Invasive mammary Carcinoma, (NST) Grade II.

Signature:

Dr. Mona Mohamed M.D

(Signature)

Pathology Lab. Manager

BASMA REFAAT M.D

Patient Name	فنديه عبدالحميد عبدالرحمن	Case No.	360803
Sex/Age	Female 73 Y	Patient No.	25858
Registered Date	26/8/2026 03:52:28 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	07/9/2026 01:25:29 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	16/9/2026 09:23:56 AM	Pathology No.	SR-943/26

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer.

Nature of Specimen: Block revision.

Gross Examination:

- One paraffin block labelled by (744 B-26).

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

-Histologic type: Invasive duct carcinoma.
- Histologic grade: 2 (differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1).
- DCIS: Absent.
- Microcalcification: Absent.
- Angiolinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.
- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): Mild.

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 5% of tumor cells (score 5/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 1+).
- Ki67%: 30%.

Conclusion:

Right breast mass, Block revision (Tru-cut biopsy):

- Invasive duct carcinoma, Grade 2.
IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 5/8).



Patient Name	فتحية عبدالصيد عبدالرحمن	Case No.	360803
Sex/Age	Female 73 Y	Patient No.	25858
Registered Date	26/8/2026 03:52:28 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	07/9/2026 01:25:29 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	16/9/2026 09:23:56 AM	Pathology No.	SR-943/26

- Her2: Low (score 1+).

- Ki67%: 30%.

****Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%; 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**** Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim. MD.



جوستاف روسي - (4) - الدار - القاهرة - مصر
 جوستاف روسي - (4) - الدار - القاهرة - مصر
 Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corridor - Mistr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient's Name:

Fathiya Abdul Hamid Abdul Rahman Ahmed

Date:

2026-08-26

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

MULTISLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST, ABDOMEN

AND PELVIS REVEALED:

Known case of breast CA.

I- CHEST:

- Right breast heterogenous parenchyma with multicentric lesions largest measuring 64 x 24 mm for sono-mammography.
- Right axillary lymph node measuring 39 x 25 mm.
- Diffuse mosaic attenuation of both lungs likely small airway disease.
- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal CT appearance of the heart and great vessels.
- Bilateral elastofibroma dorsi.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Average sized liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

Opinion:

- ❖ Right breast multicentric lesions with axillary lymphadenopathy for sono-mammography.
- ❖ No pulmonary or hepatic metastatic lesions.

Dr.sherif Wagdy



Patient's Name:

Fathiya Abdul Hamid Abdul Rahman Ahmed

Date:

2026-08-26

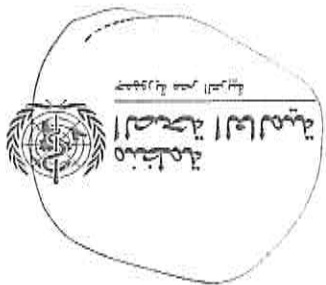
Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

Dr.sherif Wagdy



מסכת
מגילה
פרק
מגילת אסתר

2025	2025	2025	2025	2025
2026	2026	2026	2026	2026
2026	2026	2026	2026	2026
2026	2026	2026	2026	2026
2026	2026	2026	2026	2026
2027	2027	2027	2027	2027
2027	2027	2027	2027	2027
2027	2027	2027	2027	2027

[illegible]

1001	1001	1001	1001	1001
1001	1001	1001	1001	1001

☒ စာမျှင်စာမျှင် နှစ်စာမျှင် နှစ်စာမျှင်
☐ စာမျှင်စာမျှင်

စာမျက်နှာ: ၁၀၈၀၅၅ - ၁

[illegible]

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
محل: تهران



የገሥጽ ስም፡ ማርያም
የገሥጽ ስም፡ ማርያም

 מִינִיסְטֵר הַתְּחִינָה

၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

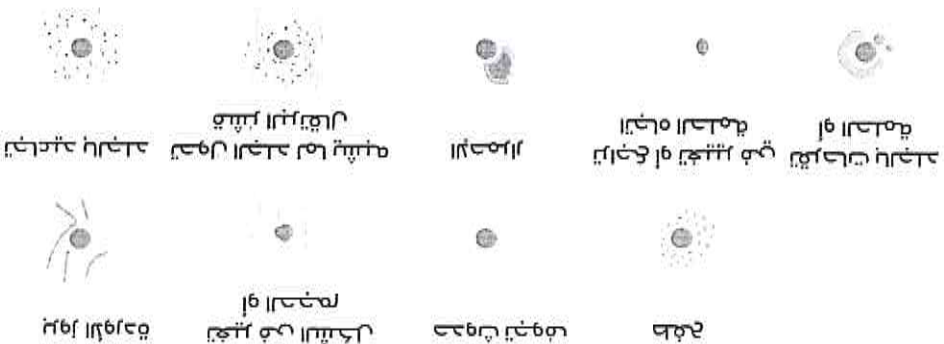
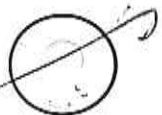
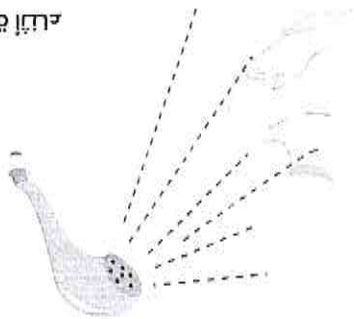
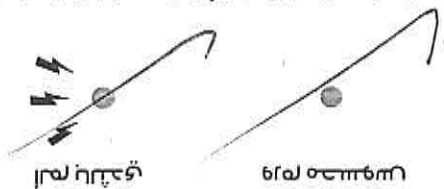
[illegible]

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်တွင်းရှိ နေပြည်တော်
 - ဘုရားရှိခိုးတော်ကြီး နေပြည်တော် အထွေထွေ အဖွဲ့အစည်း

၁၃၂၆ ခုနှစ် (၂၀၁၃ ခုနှစ်)

- (၁၄၈) နံပါတ် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

၁၄၂၆၀၀ ကုဏ်း (၂၇၈၂၀၀၀)

[illegible][illegible]

ԱՊՐԱՔՏԻՆ ԴՆՆԻՍ ԴՐՈՒՄ ԱՊՐԱՔՏԻՆ ԴԱՌՆԱ ՅԱՄ

- နေပြီ၊ ကံကောင်းတဲ့ တဲ့၊ အေးအေး၊ ကိုယ့်ကိုး

[illegible]

ስለ ለማድረግ ለሚችሉ ሰዎች
 ስለ ለማድረግ ለሚችሉ ሰዎች
 ስለ ለማድረግ ለሚችሉ ሰዎች
 - ስለ ለማድረግ ለሚችሉ ሰዎች

| ገጽ ፳፻፱ |
፳፻፱	፳፻፱	፳፻፱	፳፻፱	፳፻፱
፳፻፱	፳፻፱	፳፻፱	፳፻፱	፳፻፱
፳፻፱	፳፻፱	፳፻፱	፳፻፱	፳፻፱

၁။ ငါတို့၏ နိုင်ငံတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတော်ကို
 - ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတော်ကို
 ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတော်ကို
 - ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ နိုင်ငံတော်ကို

।।८५७०।।८।।८७ (८८।।८।।८)

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဟိမဝန္တာတောင်တန်းတန်းကြီးတစ်ခုတွင် နေထိုင်သော ရှေးဟောင်းသားများသည် မြေအောက်တွင် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။

Hand, pain full Throat
Yellowish supple discharge
- Throat Acute supple discharge
- Red - Throat Acute supple discharge
- Red - Throat Acute supple discharge